

Prueba de Actitudes ante la Alimentación

EAT-26

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria: preocupación por el peso y la comida, dieta, conductas bulímicas y control sobre la alimentación. No diagnóstica: un puntaje sobre el corte pide una entrevista clínica.

CÓMO SE APLICA

1. La persona la responde sola, marcando con una X la frecuencia de cada frase.
2. «Nunca» y «Casi nunca» valen 0, «A menudo» 1, «Muy a menudo» 2 y «Siempre» 3. La pregunta 25 se invierte: «Nunca» vale 3, «Casi nunca» 2, «A menudo» 1, y «Muy a menudo» y «Siempre» 0.
3. Se suman las 26 preguntas: el total va de 0 a 78.

Este cuestionario NO es un examen, NO hay respuestas buenas ni malas. Si en alguna pregunta no encuentras la respuesta que se ajuste exactamente a lo que piensas o haces, marca con una X la respuesta que más se le aproxime.

	Nunca	Casi nunca	A menudo	Muy a menudo	Siempre
1. Me angustia la idea de estar demasiado gorda	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
2. Procuro no comer cuando tengo hambre	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
3. La comida es para mí una preocupación habitual	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
4. He sufrido crisis de atracones en las que tenía la sensación de no poder parar de comer	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
5. Corto mis alimentos en pequeños trozos	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
6. Conozco la cantidad de calorías de los alimentos que como	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
7. Procuro no comer alimentos que contengan muchos carbohidratos (pan, arroz, papas, etc.)	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
8. Tengo la impresión de que a los demás les gustaría verme comer más	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
9. Vomito después de comer	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
10. Me siento muy culpable después de comer	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
11. Me obsesiona el deseo de estar más delgada	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
12. Cuando hago deporte pienso sobre todo en quemar calorías	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
13. Los demás piensan que estoy demasiado delgada	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
14. Me preocupa la idea de tener zonas gordas en el cuerpo y/o de tener celulitis	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
15. Tardo más tiempo que los demás en comer	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
16. Procuro no comer alimentos que tengan azúcar	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
17. Como alimentos dietéticos	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
18. Tengo la impresión de que mi vida gira alrededor de la comida	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Prueba de Actitudes ante la Alimentación (continuación)

	Nunca	Casi nunca	A menudo	Muy a menudo	Siempre
19. Tengo un buen autocontrol en lo que se refiere a la comida	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
20. Tengo la sensación de que los demás me presionan para que coma más	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
21. Paso demasiado tiempo pensando en la comida	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
22. No me siento bien después de haber tomado dulces	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
23. Estoy haciendo dieta	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
24. Me gusta tener el estómago vacío	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

	Nunca	Casi nunca	A menudo	Muy a menudo	Siempre
25. Me gusta probar platos nuevos, sabrosos y ricos en calorías	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0	☐ 0

	Nunca	Casi nunca	A menudo	Muy a menudo	Siempre
26. Después de las comidas tengo el impulso de vomitar	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Puntaje total (0 a 78)

Interpretación

Modo de corrección e interpretación

Puntaje	Interpretación
0 a 10	Por debajo del punto de corte.
11 o más	Riesgo de trastorno de la conducta alimentaria: en la validación colombiana, este corte detectó a todas las mujeres con anorexia o bulimia (sensibilidad del 100 %) con una especificidad del 85,6 %.

El corte de 11 es el de la versión colombiana de cinco opciones (Constain et al., 2014, mujeres de 15 a 25 años); el original de seis opciones usa 20 y no es comparable. Varias frases están en femenino porque la validación se hizo con mujeres: con hombres, léalas en masculino.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Garner, D. M., Olmsted, M. P., Bohr, Y. y Garfinkel, P. E. (1982). The Eating Attitudes Test: Psychometric features and clinical correlates. Psychological Medicine, 12, 871–878 · Versión colombiana de cinco opciones: Constaín, G. A., Ricardo Ramírez, C., Rodríguez-Gázquez, M. A., Álvarez Gómez, M., Marín Múnera, C. y Agudelo Acosta, C. (2014). Validez y utilidad diagnóstica de la escala EAT-26 para la evaluación del riesgo de trastornos de la conducta alimentaria en población femenina de Medellín, Colombia. Atención Primaria, 46(6), 283–289. El EAT-26 se puede usar sin costo en la práctica clínica y en investigación sin fines de lucro, citando a sus autores.